¿Persiste el impacto de vivir un terremoto con 0 a 4 años?



Shock	27-F de 2010, magnitud 8,8
Expuestos	Niños de 0 a 4 años

Efectos de shocks en la primera infancia

Peso al nacer (Torche, 2011)

Desarrollo cognitivo y no cognitivo (Gillmore, 2026)

Talla y aprendizaje (Andrabi, Daniels y Das, 2023)

Salud mental adulta (Persson y Rossin-Slater, 2018)

Este trabajo

Salud mental en la adolescencia, a los 15–18 años

¿Importa la edad en la que se vive el shock?

Los primeros años de vida son decisivos, pero no todos por igual

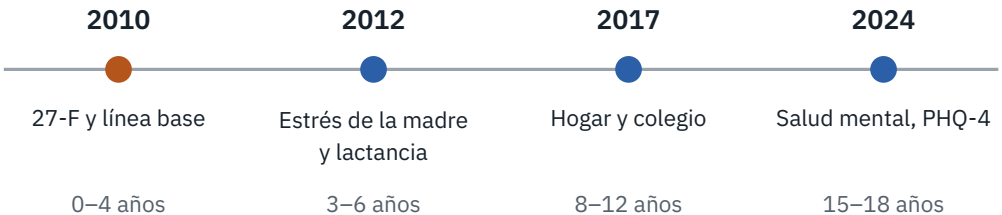
(Cunha y Heckman, 2007; Lupien et al., 2009)

Dos mecanismos posibles

	Cómo opera	A quién afecta
Entorno socioeconómico y familiar	El terremoto reduce ingresos, daña la vivienda y aumenta el conflicto entre los padres	A todos los hijos, sea cual sea su edad
Transmisión del estrés de la madre	El lactante regula su estrés a través de la madre. Si ella está estresada, se lo transmite en el contacto diario	A los lactantes, que aún dependen fisiológicamente de la madre

Entorno, Conger y Donnellan 2007; Almond, Currie y Duque 2018. Transmisión del estrés, Persson y Rossin-Slater 2018 en el embarazo; Waters, West y Mendes 2014 y Hostinar, Sullivan y Gunnar 2014 después del parto.

Qué datos utilizamos



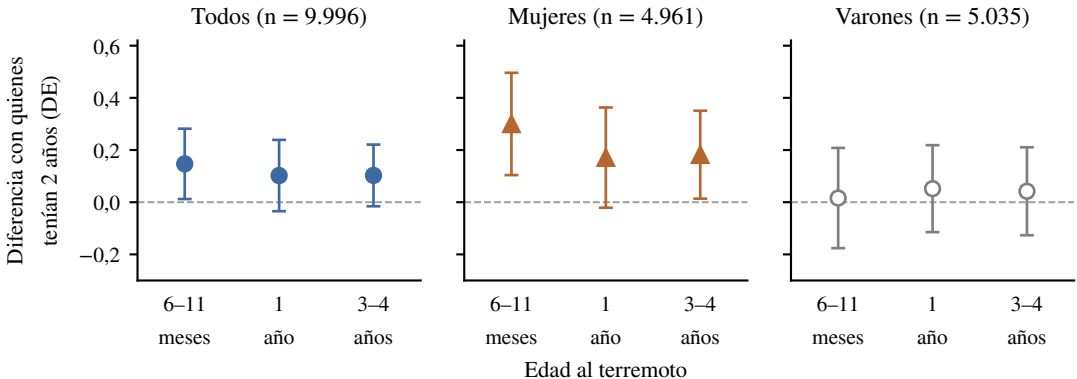
Encuesta	ELPI, Encuesta Longitudinal de Primera Infancia
Muestra	9.996 adolescentes nacidos en 2006–2009, 4.961 mujeres
Responde	La madre o el cuidador hasta 2017; el adolescente en 2024

Especificación econométrica

$$Y_{imc} = \sum_{a \neq 2} \beta_a \left(\text{Edad}_{ai} \times \text{Afectada}_m \right) + \sum_{a \neq 2} \gamma_a \, \text{Edad}_{ai} + \psi_m + \theta_c + X_i' \delta + \varepsilon_{imc}$$

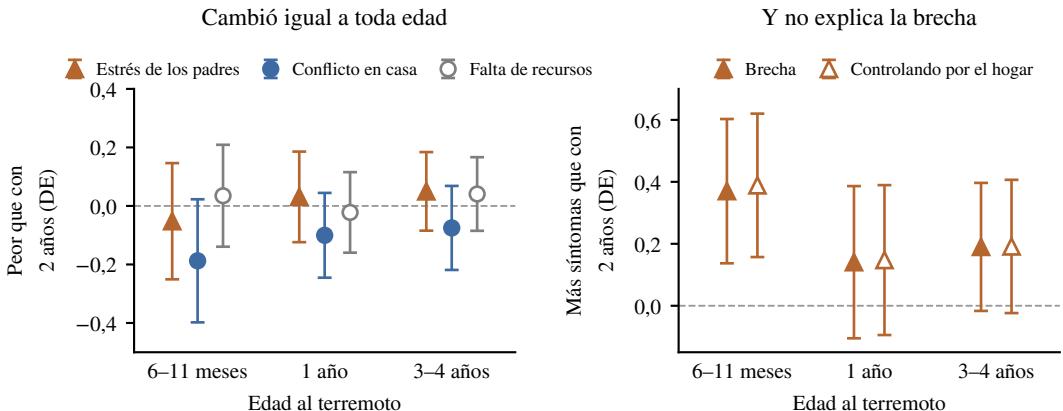
Y_{imc}	Salud mental a los 15–18 años, PHQ-4
Edad_{ai}	Edad al terremoto: 6–11 meses, 1 año o 3–4 años; referencia, 2 años
Afectada_m	Comuna en la zona de daño destructivo
β_a	Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas
ψ_m, θ_c	Efectos fijos de comuna y de cohorte de nacimiento
X_i	Controles del niño y del hogar

Efecto sobre la salud mental



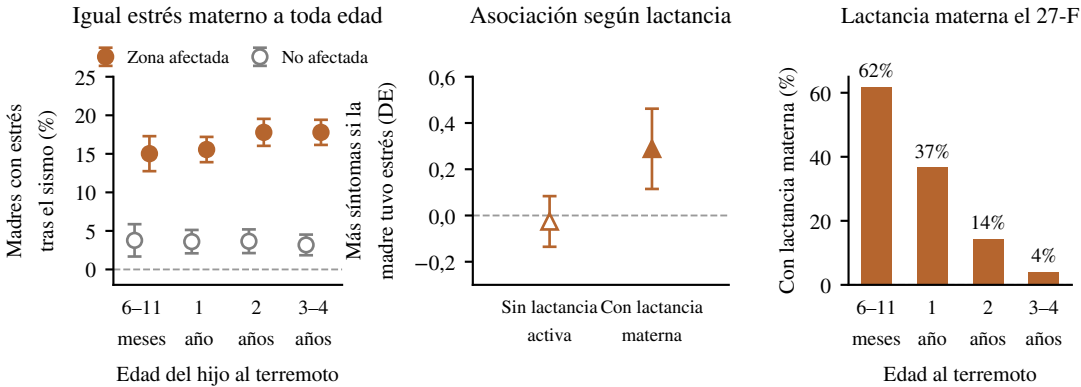
El PHQ-4 lo responde el adolescente. Son cuatro preguntas sobre las dos últimas semanas, sobre nervios, preocupación, pérdida de interés y decaimiento, que miden síntomas de ansiedad y depresión; Kroenke et al. 2009. Diferencia con quienes tenían 2 años, comunas afectadas menos no afectadas; IC al 95 %.

El entorno socioeconómico y familiar no explica la brecha



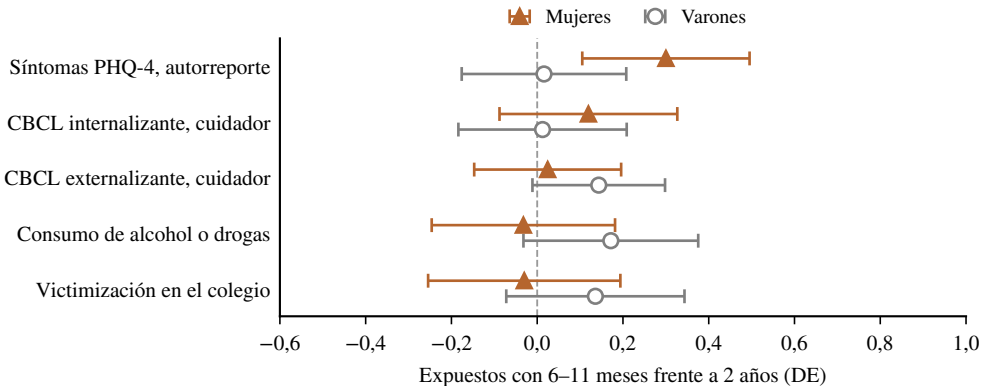
Índices de 2012 y 2017 que reporta la madre o el cuidador. Mujeres, frente a quienes tenían 2 años; IC al 95 %, a la derecha por bootstrap de comunas.

El estrés materno predice síntomas en hijas amamantadas



La lactancia materna activa el 27-F actúa como proxy de dependencia regulatoria y proximidad bioquímica/conductual con la madre. Mujeres, con EF y controles, también por educación y empleo de la madre y por edad; IC al 95 %.

En varones, solo indicios débiles en conducta y consumo



Es habitual que los padres no detecten la ansiedad y la depresión de sus hijos adolescentes; en la muestra, PHQ-4 y CBCL correlacionan 0,30; Achenbach et al. 1987; De Los Reyes et al. 2015. En varones, ambas asociaciones son significativas solo al 10 %.

Lo que sugieren los datos y lo que queda abierto

Lo que sugieren los datos

- Las expuestas entre los 6 y los 11 meses tienen peor salud mental que las expuestas a los dos años, 0,30 DE en el PHQ-4.
- El entorno socioeconómico y familiar cambió de forma similar en todas las edades y no explica esa diferencia.
- El estrés materno solo se asocia a peor salud mental en las hijas con lactancia materna, el 62 % de las expuestas entre los 6 y los 11 meses.

Lo que queda abierto

- La medida de estrés materno es binaria y retrospectiva, por lo que su contribución probablemente está subestimada.
- Qué explica el efecto a los 3–4 años, que no opera a través del entorno familiar ni del estrés materno.

En varones no hay efecto sobre la salud mental; solo indicios débiles en conducta y consumo.